

Clasificación De La Herida Operatoria

Clasificación de la Herida Operatoria

En cirugía es fundamental conocer la clasificación de la herida quirúrgica, ya que esto determina el protocolo fundamental en relación a la administración de antibióticos.

1. Herida Limpia

Se caracteriza por **no interrumpir o abrir ninguna mucosa** del organismo (solo atraviesa piel, grasa, músculo, tejido conjuntivo y vasos). - **Tratamiento Antibiótico:** Ninguno. Está proscrito debido a que el riesgo de infección es casi nulo y supera al beneficio. - **Ejemplos clásicos:** - Mastectomía. - Endarterectomía carotídea. - Cirugía cardíaca. - **Hernioplastia** (se abre la serosa peritoneal, no se perfora la víscera. Una malla protésica tampoco indica profilaxis antibiótica, aunque en la práctica a veces se deje para reducir la ansiedad del cirujano).

2. Herida Limpia-Contaminada

Ocurre cuando el cirujano intencionalmente y bajo técnica aséptica **abre una mucosa** con abundante flora bacteriana, como la del sistema genitourinario, gastrointestinal (ej. vía biliar, tubo digestivo) o respiratorio. - **Tratamiento Antibiótico: Profilaxis Antibiótica** (solamente una dosis infundida antes/durante la incisión; desde que se termina la cirugía no se prolongan). - **Ejemplos clásicos:** - Colectectomía. - Apendicectomía de un apéndice no complicado o que se seccionó proximalmente sin derrame de pus. - Cesárea (se abre mucosa endometrial). - Prostatectomía radical.

NOTA CLÍNICA

Siempre que se deba abrir una de estas mucosas sin que esté previamente infectada la serosa exterior, se cataloga como herida limpia-contaminada.

3. Herida Contaminada

La herida sufre contaminación cruzada, ya sea por ingresar en tractos inflamados no purulentos, o por la pérdida evidente y accidental de la esterilidad durante el bloque quirúrgico. - **Tratamiento Antibiótico: Profilaxis Antibiótica** o inicio inmediato preoperatorio. - **Ejemplos clásicos:** - Rotura del guante quirúrgico. - Contacto externo con un elemento no estéril (moscas, materiales mal lavados).

4. Herida Sucia o Infectada

Se constata infección preexistente. Existe tejido con macro invasión infecciosa al abrirlo, diseminación macroscópica de restos fecales, pus focalizado evidente o una necrosis supurativa previa a la incisión. - **Tratamiento Antibiótico: Tratamiento Antibiótico Pleno** (7 a 10 días totales, continuando ininterrumpidamente post-cirugía). - **Ejemplos clásicos:** - Re-exploración por celulitis o erisipela necrótica instalada. - Drenaje de un absceso franco (ej. perineal). - Perforación de colon con heces libres (peritonitis fecaloídea).

Protocolos Farmacológicos: Profilaxis versus Tratamiento

TABLA 1.3.1: CONCEPTO VS PERÍODO DE USO

CONCEPTO	PERÍODO DE USO	APLICABILIDAD
Profilaxis Antibiótica	Minutos pre-cirugía. Discontinuado tras suturar la herida.	Limpias contam., Contaminadas
Tratamiento Antibiótico	De 7 a 14 días.	Sucias (o que desarrollaron Infección Post-Qx).

Infección de la Herida Operatoria (IHO) general

La prevención de la IHO se fundamenta en los antibióticos profilácticos, pero también en: - Uso riguroso de técnica aséptica (lavado, guantes estériles, material adecuado). - Alta hospitalaria lo **antes posible** (reduce drásticamente la tasa de la colonización cruzada intrahospitalaria con patógenos resistentes como *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.*).

Conducta frente a IHO instalada

- La infección de la herida se diagnostica estrictamente con la observación clínica (eritema, descarga de pus de la zona de incisión postquirúrgica, induración dolorosa, etc).
- **Tratamiento Médico:** Curación local y cobertura con **antibióticos terapéuticos**. **NO** hay por qué re-operarla obligatoriamente, a diferencia de la dehiscencia de anastomosis, salvo raras formaciones de macro-abscesos tabicados en profundidad.
 - **Dirección Antibiótica en base a la cirugía de origen:**
 - **Origen Piel/Sin abrir mucosa:** Cobertura de Gram Positivos (*Streptococcus pyogenes*, *S. aureus*). Elección terapéutica: **Cefazolina** o **Cloxacilina**.
 - **Origen GI/Abdomen:** Gran penetración para Bacilos Gram Negativos (BGN) y anaerobios. Elección terapéutica: **Ceftriaxona + Metronidazol**.
 - **Origen Ginecológico/Cesárea:** Flora de amplio espectro vaginal con bacilos y anaerobios pélvicos. Antibióticos combinados amplios.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En una colecistitis aguda, el tratamiento primario y definitivo es **quirúrgico**. Los antibióticos que puedan administrarse durante ese proceso se proporcionan solo como profilaxis de los bordes incididos, no resuelven la colecistitis subyacente que obliga a su remoción.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una paciente de cuarenta años se opera de colecistectomía laparoscópica por colelitiasis sin colecistitis. ¿Cómo se clasifica la herida operatoria y qué antibióticos recibe?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Clasificación De La Herida Operatoria. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La herida limpia no abre mucosas y no requiere antibióticos. Ejemplos: mastectomía, hernioplastia, endarterectomía.
- La herida limpia contaminada abre mucosa gastrointestinal, genitourinaria o respiratoria y recibe profilaxis antibiótica solo durante la cirugía.
- La herida sucia o infectada está en contacto con pus o deposiciones y requiere tratamiento antibiótico completo de siete a diez días.
- La hernioplastia es herida limpia porque abre el peritoneo que es una serosa, no una mucosa, y el intestino queda indemne.
- Para infecciones de heridas digestivas se usan ceftriaxona más metronidazol; para heridas sin mucosa se usan cloxacilina o cefalosporinas.
- La profilaxis antibiótica se administra minutos antes de la incisión y no continúa después de suturar.
- El alta precoz del paciente hospitalizado reduce el riesgo de infección por gérmenes resistentes intrahospitalarios.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CLASIFICACIÓN DE LA HERIDA OPERATORIA)**PREGUNTA 1**

Una paciente de cuarenta años se opera de colecistectomía laparoscópica por colelitiasis sin colecistitis. ¿Cómo se clasifica la herida operatoria y qué antibióticos recibe?

- A)** Herida limpia, sin antibióticos
- B)** Herida limpia contaminada, profilaxis antibiótica durante la cirugía
- C)** Herida contaminada, profilaxis antibiótica
- D)** Herida sucia, tratamiento antibiótico de siete días
- E)** Herida limpia, profilaxis antibiótica de un día

PREGUNTA 2

Un paciente de cincuenta y cinco años se opera de hernioplastia inguinal sin complicaciones. ¿Qué antibióticos recibe?

- A)** Profilaxis con ceftriaxona más metronidazol durante la cirugía
- B)** Tratamiento antibiótico con cloxacilina por siete días
- C)** Sin antibióticos, porque es una herida limpia
- D)** Profilaxis con cloxacilina durante la cirugía
- E)** Tratamiento antibiótico de amplio espectro por diez días

PREGUNTA 3

Una paciente de treinta y cinco años es operada de drenaje de un absceso de pared abdominal con abundante pus. ¿Cómo se clasifica la herida y cuánto tiempo recibe antibióticos?

- A)** Herida limpia contaminada, profilaxis durante la cirugía
- B)** Herida contaminada, profilaxis durante la cirugía
- C)** Herida sucia, tratamiento antibiótico completo de siete a diez días
- D)** Herida limpia, sin antibióticos
- E)** Herida sucia, antibióticos solo durante la cirugía

RESUMEN: CLASIFICACIÓN DE LA HERIDA OPERATORIA

Las heridas operatorias se clasifican en cuatro tipos según el riesgo de infección. La herida limpia no abre ninguna mucosa y no requiere antibióticos. La herida limpia contaminada abre mucosas gastrointestinal, genitourinaria o respiratoria en condiciones controladas, y recibe profilaxis antibiótica solo durante la cirugía. La herida contaminada ocurre con tejido inflamado o falla de técnica aséptica, también recibe profilaxis. La herida sucia o infectada está en contacto con pus o deposiciones y requiere tratamiento antibiótico completo de siete a diez días. Ejemplos de cada tipo: herida limpia son la mastectomía, hernioplastia, endarterectomía y cirugía cardíaca. Herida limpia contaminada son la colecistectomía, cesárea, apendicectomía simple y prostatectomía. Herida sucia es el drenaje de abscesos y la cirugía en peritonitis. La hernioplastia es limpia aunque abre el peritoneo, porque el peritoneo es una serosa, no una mucosa, y el intestino queda indemne. La elección del antibiótico depende de la mucosa involucrada: para cirugías digestivas se usa ceftriaxona más metronidazol para cubrir gram negativos y anaerobios. Para heridas sin mucosa se cubren gram positivos con cloxacilina o cefalosporinas de primera generación. La prevención de infección de herida operatoria se basa en técnica aséptica estricta, antibióticos según la clasificación, y alta precoz del paciente hospitalizado.